KronosMedicine

Examen cronometrado: Cardiología

20 preguntas · 20 minutos
Aprobatorio: 70%

Nombre: Fecha: Calificación:

Instrucciones: lee cada caso y elige una sola respuesta. Anota tus respuestas en la hoja de respuestas. Tienes 20 minutos; empieza cuando te lo indiquen.

1. Hombre de 50 años, diabético, con TA de 148/92 en dos visitas y microalbuminuria.
¿Cuál es el fármaco de elección?

A) Hidroclorotiazida
B) Losartán
C) Propranolol
D) Hidralazina

2. Hombre de 60 años con TA 200/125, asintomático, sin alteraciones en la exploración ni en laboratorios.
¿Cuál es el diagnóstico y manejo?

A) Urgencia; fármacos orales y descenso en 24–48 h
B) Emergencia; nitroprusiato IV
C) Emergencia; nifedipino sublingual
D) No requiere tratamiento

3. Hombre de 58 años con dolor opresivo al subir escaleras que cede en 5 min al detenerse, desde hace 6 meses, sin cambios.
¿Cuál es el diagnóstico?

A) Angina inestable
B) IAM sin elevación del ST
C) Pericarditis
D) Angina estable

4. Hombre de 62 años con dolor torácico en reposo de 30 min, infradesnivel del ST en V4–V6 y troponina elevada.
¿Cuál es el diagnóstico?

A) IAM sin elevación del ST
B) Angina estable
C) Angina inestable
D) IAM con elevación del ST

5. Hombre de 55 años con dolor torácico de 2 h y elevación del ST en DII, DIII y aVF. El hospital más cercano con hemodinamia está a 3 h.
¿Cuál es la conducta?

A) Esperar la troponina
B) Trombólisis inmediata
C) Trasladar para angioplastia sin trombólisis
D) Solo aspirina y observar

6. Hombre de 60 años que tuvo un IAM hace 6 meses; LDL de 110 mg/dL con atorvastatina 10 mg.
¿Qué indicas?

A) Atorvastatina 80 mg
B) Mantener la dosis
C) Suspender la estatina
D) Solo dieta

7. Diabético de 64 años con angina y coronariografía con enfermedad significativa de 3 vasos.
¿Qué revascularización es la de elección?

A) Angioplastia de un vaso
B) Solo tratamiento médico
C) Trombólisis
D) Cirugía de revascularización (bypass)

8. Hombre de 65 años con disnea de medianos esfuerzos, edema de miembros inferiores y FEVI de 30 %, con IECA y furosemida.
¿Qué otros fármacos reducen su mortalidad?

A) Verapamilo y digoxina
B) AINE y diurético tiazídico
C) Betabloqueador, espironolactona e iSGLT2
D) Nifedipino

9. Mujer de 70 años con disnea súbita, estertores bilaterales, $SatO_2$ 85 % y TA de 180/100.
¿Qué combinación es la más adecuada?

A) Solución salina 2 L
B) Oxígeno, furosemida IV y nitroglicerina
C) Dobutamina sola
D) Betabloqueador IV a dosis alta

10. Hombre de 72 años, hipertenso y diabético, con FA permanente y frecuencia controlada.
¿Qué tratamiento antitrombótico indicas?

A) Ninguno
B) Aspirina
C) Anticoagulante oral (p. ej., apixabán)
D) Clopidogrel

11. Mujer de 28 años con palpitaciones de inicio súbito, FC 190, QRS estrecho regular, TA normal.
¿Cuál es el primer paso?
A) Cardioversión eléctrica
B) Amiodarona IV
C) Maniobras vagales
D) Digoxina

12. ECG con PR que se prolonga progresivamente hasta que una onda P no se sigue de QRS.
¿Qué bloqueo es?
A) Mobitz I
B) Primer grado
C) Mobitz II
D) Tercer grado

13. Joven de 20 años con ECG en reposo con PR de 100 ms y empastamiento inicial del QRS.
¿Cuál es el hallazgo?
A) Bloqueo AV de primer grado
B) Bloqueo de rama derecha
C) Hipertrofia ventricular
D) Preexcitación (patrón WPW)

14. Hombre de 30 años usuario de drogas IV con fiebre, soplo sistólico que aumenta con la inspiración y nódulos pulmonares.
¿Cuál es el agente más probable?
A) Streptococcus viridans
B) Candida albicans
C) Staphylococcus aureus
D) Enterococcus faecalis

15. Hombre de 25 años con dolor torácico punzante que mejora al inclinarse hacia adelante, tras un cuadro gripal. ECG con elevación difusa del ST y depresión del PR.
¿Cuál es el tratamiento?
A) Trombólisis
B) Ibuprofeno + colchicina
C) Anticoagulación
D) Angioplastia primaria

16. Hombre de 78 años con síncope de esfuerzo y soplo sistólico expulsivo en foco aórtico irradiado a carótidas.
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Estenosis aórtica
B) Insuficiencia mitral
C) Estenosis mitral
D) Comunicación interauricular

17. Mujer de 32 años con disnea progresiva, hemoptisis y soplo diastólico en retumbo con chasquido de apertura.
¿Cuál es la causa más probable?
A) Endocarditis
B) Fiebre reumática
C) Isquemia
D) Válvula bicúspide

18. Paciente con soplo holosistólico en el borde esternal izquierdo bajo que aumenta con la inspiración.
¿Qué valvulopatía es?
A) Insuficiencia mitral
B) Estenosis aórtica
C) Estenosis pulmonar
D) Insuficiencia tricuspídea

19. Joven de 17 años con HTA en brazos, pulsos femorales débiles y soplo interescapular.
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) HTA esencial
B) Feocromocitoma
C) Estenosis renal
D) Coartación de la aorta

20. Hombre hipertenso de 60 años con dolor torácico súbito desgarrante irradiado a la espalda y diferencia de TA entre brazos de 30 mmHg.
¿Qué estudio confirma el diagnóstico si está estable?
A) Angiotomografía de aorta
B) Prueba de esfuerzo
C) Troponina
D) Gammagrafía